

Cztery fazy — *cztery objawy*

Estrogen moduluje dopaminę. Cykl, ciąża, połóg, menopauza — każda zmienia ADHD u kobiety. Wiedza zmienia leczenie.

CZAS: 10 min czytania Pogłębienie po karcie „kobiety z ADHD”

ŹRÓDŁO: Quinn i Madhoo (2014); Haimov-Kochman i Berger (2014); Roberts i wsp. (2018)

JAK UŻYWAĆ

Naucz się **czterech faz hormonalnych** wpływających na ADHD: cykl miesięczny, ciąża, połóg, perimenopauza/menopauza. Zaczniij **dziennik objawów** + cyklu przez 3 miesiące — to dane diagnostyczne. Porozmawiaj z psychiatrą o *dostosowaniu dawki* leku w fazach pogorszenia.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Estrogen **moduluje system dopaminowy** i serotoninowy — dokładnie te same systemy, które są dysregulowane w ADHD. Quinn i Madhoo (2014, *Postgraduate Medicine*): wahania estrogenu wpływają **bezpośrednio** na objawy ADHD u kobiet. **Wysoki estrogen = lepsze funkcjonowanie** ADHD. **Niski estrogen = nasilenie objawów**. To wyjaśnia: dlaczego objawy nasilają się przed miesiączką, dlaczego ciąża czasem przynosi ulgę (lub jej brak), dlaczego połóg dramatycznie pogarsza, dlaczego wiele kobiet jest **diagnozowanych dopiero w perimenopauzie**. Haimov-Kochman i Berger (2014): hormonalna terapia zastępcza może wspomagać leczenie ADHD w menopauzie.

01 Cztery fazy — wpływ na ADHD

1 · CYKL MIESIĘCZNY

Faza folikularna (po miesiączce, ~14 dni): estrogen rośnie — funkcjonowanie lepsze. **Faza lutealna** (~14 dni do miesiączki): estrogen spada — objawy ADHD nasilają się + PMS.

2 · CIAŻA

Zmienne. *II-III trymestr*: wysoki estrogen może **poprawiać** objawy. Ale ważne: **nie wszystkie leki** są bezpieczne w ciąży. Decyzja indywidualna z psychiatrą i ginekologiem/-iczką.

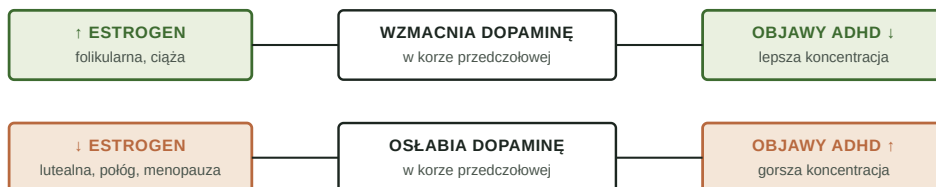
3 · POŁÓG

Dramatyczny spadek estrogenu po porodzie. Objawy ADHD często *poważnie się nasilają*. Ryzyko depresji poporodowej u kobiet z ADHD jest 2-3x wyższe. Sygnał alarmowy.

4 · PERI-/MENOPAUZA

Stopniowy spadek estrogenu. **Wiele kobiet diagnozuje się dopiero teraz** — bo wcześniej estrogen „maskował” objawy. Możliwa: hormonalna terapia zastępcza (HTZ) + dostosowanie leku.

02 Mechanizm — estrogen i dopamina



Wniosek kliniczny: objawy ADHD u kobiety to *nie stała* intensywność. Zmieniają się **z hormonami**. Lek o stałej dawce może być za słaby w fazie lutealnej i wystarczający w folikularnej. To *realny* argument do rozmowy z psychiatrą o dostosowaniu dawkowania.

03 Dziennik cyklu i ADHD — 3 miesiące

Codziennie zaznacz fazę cyklu i intensywność objawów ADHD (1–10). Po 3 miesiącach widać **jasny wzorzec**. Pokaż psychiatrze.

DZ. CYKLU	FAZA <i>menstr / fol / owul / luteal</i>	OBJ. ADHD <i>1–10</i>	NASTRÓJ <i>1–10</i>	ENERGIA <i>1–10</i>
<i>1–5</i>				
<i>6–10</i>				
<i>11–14</i>				
<i>15–18</i>				
<i>19–22</i>				
<i>23–28</i>				

04 Strategie dla każdej fazy

FAZA LUTEALNA (PMS)

Mniej obciążeń. Większy bufor czasowy. Dłuższe sesje pracy głębszej w fazie folikularnej, mniej w lutealnej. Rozmowa z psychiatrą o czasowym dostosowaniu dawki.

CIAŻA

Konsultacja z psychiatrą i ginekologiem/-iczką jeszcze *przed* ciążą. Ocena: leki, alternatywy, monitoring. Nie odstawiaj samodzielnie.

POŁÓG

Plan zapobiegania: wsparcie partnera/rodziny, ograniczenie obowiązków, ewentualnie wznowienie/rozpoczęcie leku. *Sygnaty alarmowe:* depresja poporodowa — natychmiast do lekarza.

PERI-/MENOPAUZA

„Dawałam radę, teraz nie” → konsultacja. Możliwa **hormonalna terapia zastępcza (HTZ)** + dostosowanie leku ADHD. Decyzja ginekolog/-iczka + psychiatra/-tra.

Klucz: Quinn (2005): *„Lekarze, którzy nie wiedzą o wpływie hormonów na ADHD u kobiet, leczą połowę problemu”*. Roberts i wsp. (2018): kobiety z ADHD, które prowadzą **dziennik objawów + cyklu** i rozmawiają z lekarzem o dostosowaniu, raportują o $d = 0,6$ lepszą subiektywną kontrolę objawów. *Nie jesteś niestabilna* — Twój estrogen się waha. Wiedza o tym to **pierwszy krok**, by przestać czuć, że *„czasem dajesz radę, a czasem nie umiesz”*.